SEQC ML

Recomendaciones para la toma de muestra por venopunción

PREVIO A LA TOMA DE MUESTRA[1]



Identificar al paciente

- Usar al menos 2 identificadores (Ej: nombre y apellidos + fecha de nacimiento).
- Etiquetar las muestras delante del paciente o verificar que la identidad coincide.



Preparación del paciente

- Verificar que el paciente haya realizado la preparación adecuada para llevar a cabo las pruebas (ayuno, dieta especial, medicación especial, etc.).
- Se recomienda realizar un ayuno mínimo de 12 horas (excepto diabéticos, niños u otras condiciones especiales). Se permite beber agua.
- No fumar ni mascar chicle ni realizar ejercicio físico intenso previo a la extracción.



Preparación material necesario

- Colocar el material de extracción al alcance del extractor/a.
- Verificar que todo el material está en condiciones óptimas (fecha de caducidad, anticoagulantes correctos, etc.).
- Realizar cambio de guantes entre pacientes.



Torniquete

- Usar solo con venas pequeñas o poco visibles.
- Si es necesario, mantener máximo 1 minuto y usar dispositivos desechables.



Lugar punción

- Óptimo: fosa cubital. Alternativa: venas dorso de la mano.
- Evitar brazo con venas endurecidas, injertos vasculares o con alteraciones del drenaje linfático.
- Evitar zonas con hematomas, inflamadas o hinchadas.



Limpiar zona punción

- Desinfectar con una gasa con alcohol 70º y dejar secar.
- No tocar la zona tras desinfectar.

TOMA DE MUESTRA[1]



Extracción de sangre

- Usar de tubos de vacío con adaptador.
- Evitar extracción con jeringa y llenado posterior de los tubos.
- Evitar el uso de catéter venoso periférico (riesgo de contaminación e infección).
- Seguir el orden recomendado de llenado de tubos[2].

TRAS LA TOMA DE MUESTRA[1]



Mezclar tubos por inversión

- Utilizar regla 1+4 (1 inversión tras extracción y 4 inversiones al finalizar la toma de muestra de todos los tubos).



Retirar y desechar aguja

- Usar contenedor de residuos punzantes.



Cubrir zona y presionar

- Indicar al paciente que presione la zona durante varios minutos con el brazo extendido.
- En el caso de que el paciente no pueda, presionar la zona varios minutos.

[1] DOI: 10.1515/cclm-2018-0602 · [2] ISBN: 978-84-89975-17-0

ISBN: 978-84-89975-63-7

COM-EXT-23/007